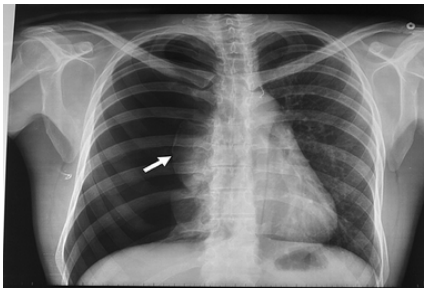
TRAUMA TORÁCICO

DR. GERARDO VICTORIA

LESIONES TORÁCICAS QUE MATAN RÁPIDO

- Neumotórax a tensión: desviación traqueal, ausencia de ruidos respiratorios e ingurgitación yugular; se descomprime con aguja y luego tubo torácico, sin esperar imágenes.
- Neumotórax abierto: herida succionante; se sella con un apósito de 3 puntas y se coloca un tubo torácico.
- Hemotórax masivo: más de 1500cc iniciales o más de 200cc/h; requiere tubo torácico y, si no cede, toracotomía.



HEMOTÓRAX

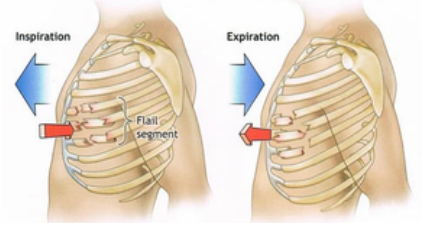
- Tubo de tórax si >500 mL en estables; <300 mL se observan.
- Producción normal 100–150 mL/día; retirar el tubo con débito <100 mL/24 h y sin oscilación.

HEMOTÓRAX RETENIDO

- Primera causa de empiema traumático: VATS en las primeras 72 h, sin colocar un segundo tubo.

TÓRAX INESTABLE

- Fractura doble de ≥3 costillas contiguas: movimiento paradójico.
- Lo grave es la contusión pulmonar (atelectasia, alteración V/Q, insuficiencia respiratoria): analgesia multimodal (bloqueos intercostales o epidural), manejo de secreciones y rehabilitación precoz.

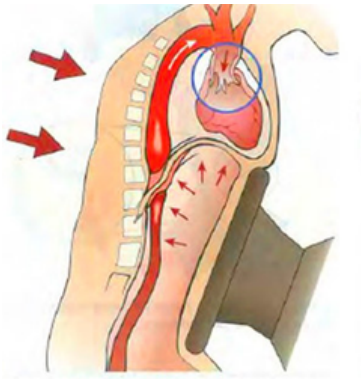


TAPONAMIENTO CARDÍACO

- Heridas en el área de riesgo cardíaco (entre líneas medioclaviculares y reborde costal).
- Tríada de Beck solo en 20–25%; diagnóstico por ecografía (colapso diastólico del VD) o ventana pericárdica subxifoidea.

RUPTURA AÓRTICA TRAUMÁTICA

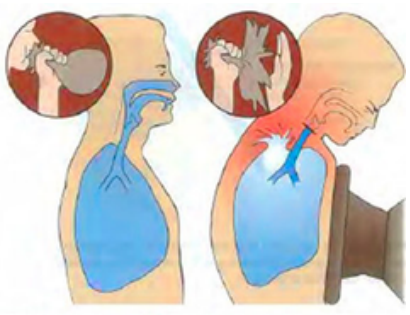
- Segunda causa de muerte por trauma; desaceleración con fijación en el ligamento arterioso (distal a la subclavia izquierda).
- Mediastino ensanchado >8–10 cm; diagnóstico por angioTAC; tratamiento: reparación endovascular con endoprótesis.



Rotura de la aorta por compresión abdominal

LESIONES ASOCIADAS A CONSIDERAR

- Contusión pulmonar: puede empeorar en las primeras 24-48h; vigilar la oxigenación de cerca.
- Ruptura diafragmática: sospechar si se ve la sonda nasogástrica dentro del tórax en la radiografía.



Rotura pulmonar por compresión torácica

TRAUMA TORÁCICO

DR. GERARDO VICTORIA

EVALUACIÓN INICIAL (ATLS)

- Vía aérea con control de columna cervical, respiración y circulación: se identifican y tratan primero las lesiones que matan.
- Radiografía de tórax y FAST: estudios iniciales en el paciente inestable.
- La reevaluación constante es clave: el estado del tórax puede cambiar en minutos.

EFAST

- Prueba estándar en el inestable: neumotórax, hemotórax, taponamiento y líquido libre (4 ventanas: cuadrante superior derecho e izquierdo, subxifoidea e hipogastrio).

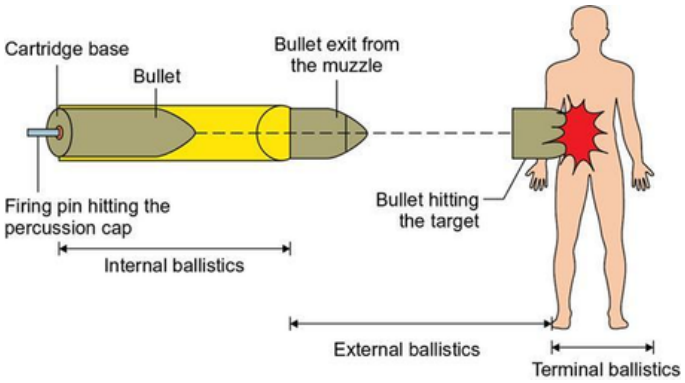


MANEJO DEL DOLOR Y REHABILITACIÓN

- Analgesia adecuada, incluyendo bloqueos regionales, mejora la mecánica ventilatoria y reduce complicaciones pulmonares.
- Fisioterapia respiratoria temprana en todo trauma torácico, sobre todo con fracturas costales múltiples.

BALÍSTICA

- El daño lo causa la onda cinética expansiva, no solo la trayectoria; la onda de succión arrastra ropa, piel y contaminantes a la pleura: antibióticos profilácticos.



TUBO TORÁCICO Y TORACOTOMÍA

- Indicaciones de tubo torácico: neumotórax, hemotórax o hemoneumotórax.
- Toracotomía de reanimación: pérdida de signos vitales presenciada, principalmente en trauma penetrante de tórax.
- Toracotomía urgente: hemotórax masivo inicial o sangrado persistente por el tubo torácico.

